Berufsverband der Coloproktologen Deutschlands e.V. (BCD)
info@coloproktologen.de
www.coloproktologen.de

Deutsche Gesellschaft für Koloproktologie e.V. (DGK)
info@koloproktologie.org
www.koloproktologie.org

Stellungnahme zur

„Stationären oder ambulanten Operation“ beim Pilonidalsinus

Beim Pilonidalsinus kommen drei unterschiedliche Operationsverfahren zur Anwendung. Neben der ausgedehnten, offenen Exzision und der limitierten Mini-Excision jeweils mit nachfolgender Sekundärheilung werden unterschiedliche Verfahren mit Exzision und primärem Wundverschluss – zum Teil unter plastischer Defektdeckung – durchgeführt. Diese letztgenannten Verfahren können im Einzelfall eine sehr aufwendige Verschiebung von Haut- und Weichteilgewebe bedingen. Sie bergen zudem ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko. Somit sind sie nicht regelhaft zur ambulanten Durchführung geeignet.

Die offene Exzision kann beim geeigneten Patienten und wenn der Befund lokal begrenzt ist (z.B. Wundfläche kleiner als 5 x 3 cm), durchaus ambulant durchgeführt werden. Zu berücksichtigen ist die häufige Nachblutungsgefahr aufgrund des Ausmaßes der Operationswunde, die im Einzelfall präoperativ nicht abschätzbar ist. Bei größeren Exzisionen und häufig bei Rezidiveingriffen ist primär eine stationäre Versorgung erforderlich.

Die Entscheidung zur ambulanten oder stationären Durchführung proktologischer Operationen muss neben den üblichen Kontraindikationen (Begleiterkrankungen, häusliches Umfeld, psychische Verfassung des Patienten) insbesondere das zu erwartende Ausmaß der Wunden, sowie die daraus resultierende Schmerzhaftigkeit vor dem Hintergrund der individuellen Schmerzempfindlichkeit des Patienten berücksichtigen.

Freiburg, Mai 2020

Dr. B. Strittmatter
Vorsitzender BCD

Prof. Dr. A. Herold
Generalsekretär DGK

Geschäftsstelle
Maienstraße 3 Tel.: 0761/70438-113
79102 Freiburg Fax: 0761/70438-114